



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

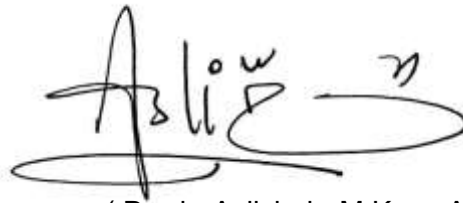
Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2025

Disusun oleh:
Kepala Instalasi Farmasi



(apt. Laili Choirul Umma, S.Farm)

Disetujui oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi Rumah Sakit ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi Rumah Sakit mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PENYUSUN

1. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep
2. apt. Laili Choirul Umma, S.Farm
3. apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm
4. apt. Shinta Aprillia Rizky, S.Farm
5. apt. Laili Choirul Umma, S.Farm
6. apt. Miftakhul Rohmah Putri, S.Farm
7. apt. Yolanda Riskawasianda Y, S. Farm
8. apt. Nur Intan Permatasari , S.Farm
9. apt. Lilis Ika K, S. Farm
10. apt. Dita Nurul Aini, S.Farm
11. apt. Ledyna Astri O, S. Farm
12. apt. Permata Sari Pratiwi, S. Farm
13. apt. Rohmah Madya Ayu Fitriana, S.Farm
14. Sinta Dewi Novitasari, A.Md.Farm
15. Siti Alisia Arti, A.Md. Farm
16. Siti Nasiha, A.Md. Farm
17. Agung Prabowo, Amd. Farm
18. Tiffani Andika, A.Md. Farm
19. Amilia Dwi Lismawati, A.Md. Farm
20. Ayu Indra Irmia, Amd.Farm
21. Widiya Fatmawati
22. Olivia Febriani, S.Farm
23. Windi Kartikasari, A.Md.Farm
24. Khopnia, A.Md. Farm
25. Niken Dewi Hastuti, S. Farm
26. Dimastika Purihita H., A.Md. Farm
27. Della Anasya N., A.Md. Farm
28. Ivan Fadila, A.Md. Farm
29. Chela Meidita Elsa Putri
30. Ayutya Helgayanti, S. Farm
31. Intan Larasati, A.Md. Farm
32. Putri Oktavia Larasati, A.Md. Farm
33. Umus Salamahhh, A.Md.Farm
34. Sheila Luthfi Sabrina, A.md.Farm
35. Anggun Salsabila S, A.Md. Farm
36. Nur fitriyani, A.Md. Farm
37. Khoirun Nisa, S. Farm
38. Anisah Kurniawati, A.Md. Farm
39. Chessia Jeseloy C P., A.Md. Farm
40. Lolita Indriani Putri, S. Farm
41. Khoirun Najwa, A.Md. Farm
42. Adelia Maharani, A.Md. Farm
43. Sintia Anggriani, A.md. Kes

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI	v
PERATURAN DIREKTUR	1
BAB I	
PENDAHULUAN	4
BAB II	
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	5
2.1 DESKRIPSI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	5
2.2 SEJARAH INSTITUSI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA.....	5
BAB III	
VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN.....	6
3.1 VISI	6
3.2 MISI	6
3.3 FALSAFAH	6
3.4 LANDASAN 7 NILAI BUDI UTAMA	6
3.5 TUJUAN	6
3.6 MOTTO	6
BAB IV	
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT.....	7
4.1 KETERANGAN/PENGERTIAN	8
BAB V	
STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI.....	10
5.1 STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	10
BAB VI	
URAIAN JABATAN	11
6.1 URAIAN JABATAN	11
6.2 TUGAS KLINIS	17
BAB VII	
TATA HUBUNGAN KERJA	22
7.1 TATA HUBUNGAN KERJA	22
7.2.1 POLA HUBUNGAN DENGAN INSTALASI/UNIT PELAYANAN STRUKTURAL	23
7.2.2 POLA HUBUNGAN DENGAN INSTALASI/UNIT PENUNJANG	25
BAB VIII	
POLA KETANAGAAAN.....	26
8.1 POLA KETENAGAAAN	26
8.2 PENEMPATAN DAN PENEMPATAN KEMBALI STAF	26
8.3 EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN STAF	27
8.4 SELEKSI CALON STAF	28
8.5 PENGEMBANGAN STAF	28
BAB IX	
KEGIATAN ORIENTASI.....	30
9.1 ORIENTASI APOTEKER	30
9.2 ORIENTASI TENAGA VOKASI FARMASI	32
BAB X	
PERTEMUAN RAPAT	34
BAB XI	
PELAPORAN	35



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR : 935.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Menimbang : bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 0306/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2018 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1335/2024 tentang Standar Kompetensi Tenaga Vokasi Farmasi
 13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/II/2022 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
 14. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
2. Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit dengan nama jabatan kepala, direktur utama atau direktur.
3. Pasien adalah setiap orang yang melaksanakan konsultasi dilema kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
4. Profesional Pemberi Asuhan yang selanjutnya disebut PPA yaitu tenaga-tenaga yang berkewajiban memberikan asuhan meliputi dokter, dokter spesialis, apoteker, dietisien/nutrisionis, perawat, bidan, fisioterapi dan tenaga kesehatan yang lain.
5. Tenaga Kesehatan yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta mempunyai pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan.
6. Keluarga Pasien adalah setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
7. Pengunjung Rumah Sakit adalah setiap orang yang datang mengunjungi Rumah Sakit untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan yang lain.
8. Masyarakat Sekitar Rumah Sakit adalah sekumpulan orang yang tinggal dan/atau berinteraksi di area sekitar Rumah Sakit.
9. Komunikasi efektif dalam Promosi Kesehatan Rumah Sakit adalah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui cara/media tertentu sehingga orang lain tersebut memahami apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau pemberi informasi.
10. SBAR adalah singkatan dari *Situation, Background, Assessment, Recommendation* adalah suatu teknik atau cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan tepat. Teknik komunikasi ini digunakan dalam bidang pelayanan kesehatan, khususnya diantara para profesional, misalnya antara profesi kedokteran dan keperawatan sebagai *handover*, konsul lisan atau melaporkan nilai kritis.
11. CPPT adalah singkatan dari Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (*integrated note*) adalah dokumentasi para profesional pemberi asuhan tentang perkembangan kondisi pasien terintegrasi pada format baku dalam rekam medis pasien.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Prima Husada.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini.

Pasal 4

Peraturan direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
NOMOR 935.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI
FARMASI

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan memberikan dua jenis pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Pedoman organisasi rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit harus melaksanakan beberapa fungsi, satu diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan nonmedik. Dalam hal penunjang medik, salah satu pelayanan yang penting adalah pelayanan farmasi. Instalasi farmasi di rumah sakit merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang mengadakan barang farmasi yang beredar di rumah sakit serta bertanggung jawab atas pengadaan dan penyajian informasi obat yang siap pakai bagi semua pihak di rumah sakit, baik petugas maupun pasien. Instalasi farmasi di rumah sakit harus memiliki organisasi yang dipimpin oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga vokasi farmasi.

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
NOMOR 935.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI
FARMASI

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FARMASI

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan memberikan dua jenis pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, rehabilitasi medis dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Pedoman organisasi rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit harus melaksanakan beberapa fungsi, satu diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan nonmedis. Dalam hal penunjang medis, salah satu pelayanan yang penting adalah pelayanan farmasi. Instalasi farmasi di rumah sakit merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang mengadakan barang farmasi yang beredar di rumah sakit serta bertanggung jawab atas pengadaan dan penyajian informasi obat bagi semua pihak di rumah sakit, baik petugas pemberi asuhan (PPA) maupun pasien. Instalasi farmasi di rumah sakit harus memiliki organisasi yang dipimpin oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga vokasi farmasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1. DESKRIPSI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Jalan Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan, Telepon (0343) – 6745000, Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com , website : www.rs-primahusada.com

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Umum & Keuangan, dalam tugasnya dibantu oleh para Kepala Instalasi dan Kepala Unit.

Rumah Sakit Prima Husada menyediakan beberapa pelayanan yang meliputi: pelayanan Instalasi Gawat Darurat 24 Jam, Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari ruang isolasi, Kelas I,II,III dan VIP, Instalasi Kamar Operasi, *Intensive Care Unit*, *Neonatal Intensive Care Unit*, Hemodialisa, Pelayanan Poli Spesialis yang terdiri dari pelayanan spesialis anak, spesialis bedah, spesialis bedah tulang, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, spesialis mata, spesialis kandungan, spesialis syaraf, spesialis urologi, spesialis bedah plastik, spesialis paru, spesialis mata, spesialis kesehatan jiwa, spesialis kulit dan kelamin, spesialis telinga hidung tenggorokan, spesialis anastesi, pelayanan gigi dan gigi anak. Selain itu juga membuka pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi dan pelayanan rehabilitasi medik.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 SEJARAH INSTITUSI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan:

Tahun 2018	: Pengajuan ijin Rumah Sakit Prima Husada 27
Desember 2018	: Ijin operasional keluar.
9 Januari 2019	: Rumah Sakit Prima Husada diresmikan oleh Bupati Kabupaten Pasuruan.
11 Januari 2019	: Rumah Sakit Prima Husada menerima pasien serta dilakukan bimbingan akreditasi.
23 April 2019	: Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah melaksanakan Akreditasi Versi SNARS Edisi 1.
07 Desember 2022	: Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah melaksanakan Akreditasi Versi STARKES 2022.

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN

3.1 VISI

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memiliki visi:

“Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2 MISI

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memiliki misi:

1. Memberi pelayanan kesehatan dengan amat, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3. FALSAFAH

Memberikan pelayanan secara profesional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4. LANDASAN 7 NILAI BUDI UTAMA

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama:

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

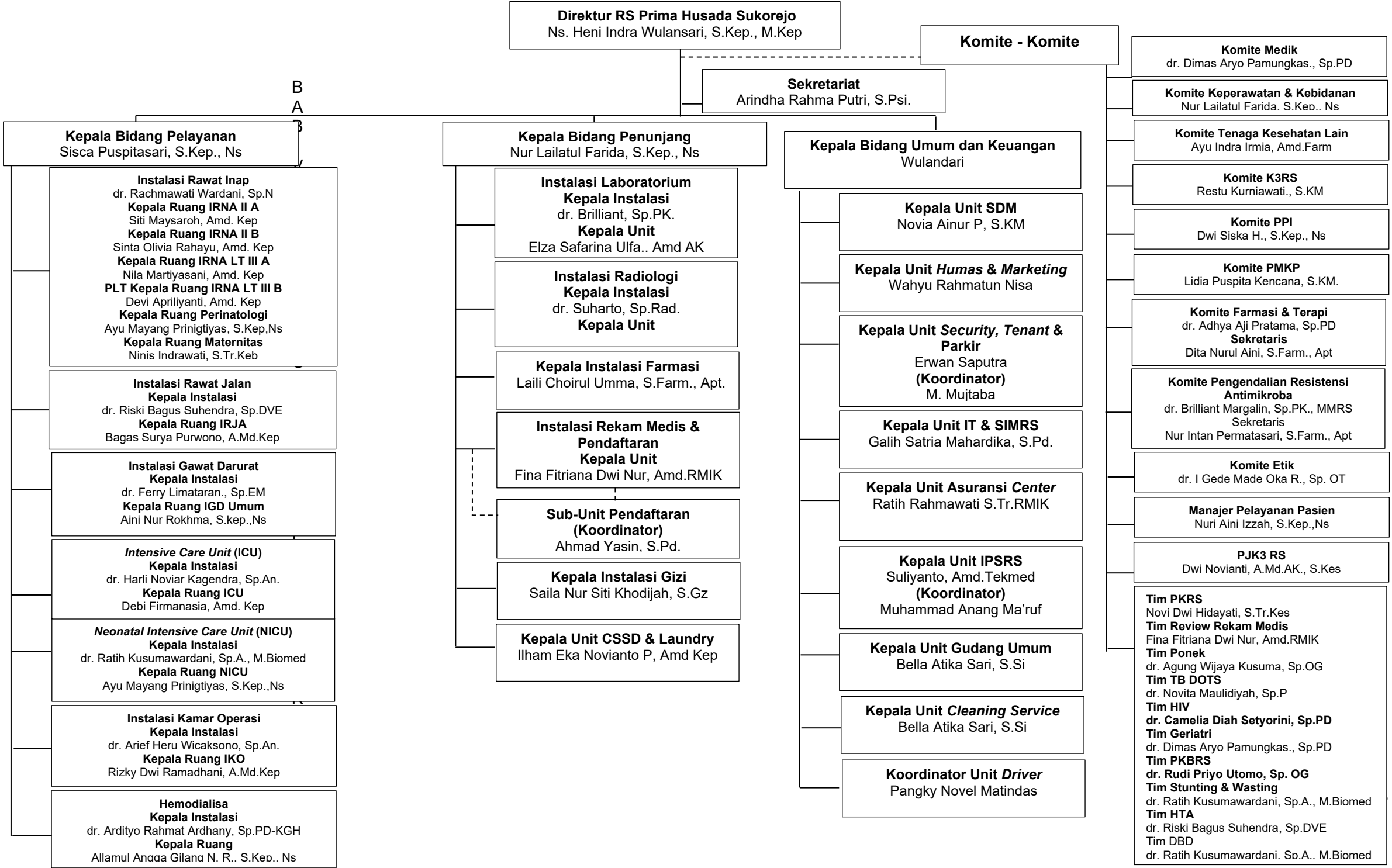
3.5. TUJUAN

Rumah Sakit Prima Husada menjadi Rumah Sakit yang memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya.

3.6. MOTTO

“Sahabat Menuju Sehat”.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT



4.1 Keterangan/Pengertian

1. Unit Struktural

- Direktur Rumah Sakit
Adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
 - Kepala Bidang
Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu:
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
 - 2) Kepala Bidang Penunjang membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
 - 3) Kepala Bidang Umum dan Keuangan membantu Direktur dalam bagian :
 - SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - Umum meliputi : Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Humas dan Pemasaran dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.
-
- ~~Sistem Manajemen Rumah Sakit~~
 - Kepala Instalasi, Kepala Unit dan Kepala Ruang
Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala Instalasi, Kepala Unit, Kepala Ruang dan Koordinator :

- a. Kepala Instalasi Rawat Jalan
- b. Kepala Instalasi Kamar Operasi
- c. Kepala Instalasi Gawat Darurat
- d. Kepala Instalasi Farmasi
- e. Kepala Instalasi Hemodialisa
- f. Kepala Unit Rekam Medis
- g. Kepala Unit Laboratorium
- h. Kepala Unit Radiologi
- i. Kepala Unit Gizi
- j. Kepala Unit Laundry
- k. Kepala Unit CSSD & Laundry
- l. Kepala Unit SDM
- m. Kepala Unit IT & SIMRS
- n. Kepala Unit Asuransi Center
- o. Kepala Unit Humas & Marketing
- p. Kepala Unit *Security & Tenant*
- q. Kepala Unit IPSRS
- r. Kepala Unit Gudang Umum
- s. Kepala Unit *Cleaning Service*
- t. Kepala Ruang Rawat Inap
- u. Kepala Ruang *Intensive Care Unit*
- v. Kepala Ruang *Neonatal Intensive Care Unit*
- w. Koordinator Pendaftaran
- x. Koordinator Driver
- y. Koordinator Parkir

2. Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan

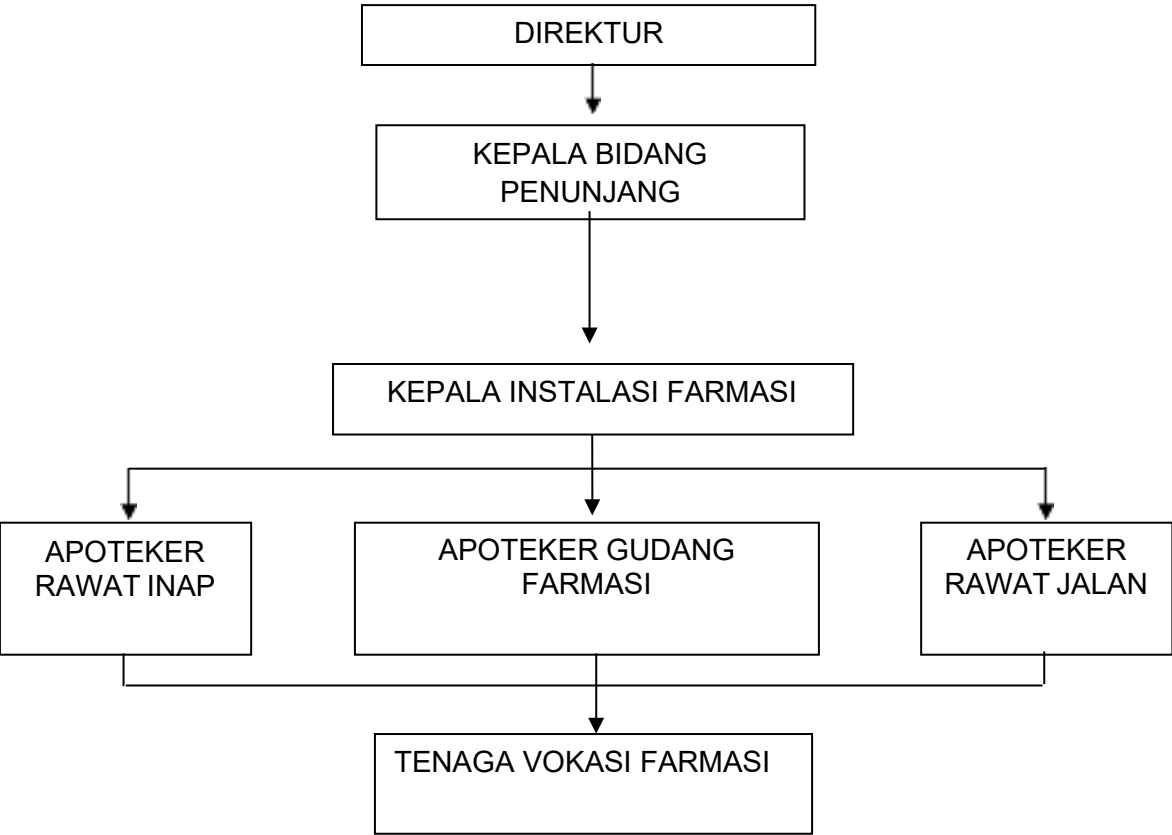
pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/Panitia/Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah sebagai berikut:

- Komite Medik
- Komite Keperawatan & Kebidanan
- Komite Tenaga Kesehatan Lain
- Komite K3RS
- Komite PPI
- Komite PMKP
- Komite Farmasi & Terapi
- Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- Komite K3RS
- Komite Etik
- Manajer Pelayanan Pasien
- PJK3 RS
- Tim PKRS
- Tim Review Rekam Medis
- Tim TB DOTS
- Tim PONEK
- Tim Geriatri
- Tim HIV
- Tim PKBRS
- Tim *Stunting & Wasting*
- Tim HTA
- Tim DBD

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI

5.1 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



BAB VI

URAIAN JABATAN

6.1 URAIAN JABATAN

No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
1	Kepala Instalasi Farmasi	1. Pendidikan : - Lulusan S1 Apoteker - Memiliki STRA Seumur Hidup dan SIPA Apoteker Penanggung Jawab yang masih berlaku, Surat Sumpah Apoteker 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 2 tahun 4. Uraian tugas • Menyusun dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran Instalasi Farmasi terkait SDM, Fasilitas, Pengembangan Pelayanan, Mutu, Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja Instalasi Farmasi disesuaikan dan/atau berdasarkan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. • Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Farmasi dan melaksanakannya. • Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. • Menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas dan hal-hal terkait di unitnya. • Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. • Menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit. • Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. • Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggungjawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas. • Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap apoteker pendamping dan pelaksana. • Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. • Memastikan proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Memastikan pelayanan pasien sesuai pedoman pelayanan farmasi dan standar prosedur operasional yang berlaku. • Memelihara peralatan medis agar selalu dalam

		keadaan baik dan siap pakai. • Melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit. • Menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. • Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama staf maupun pasien dan keluarganya. • Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. • Menjaga proses kontrol mutu terhadap ikatan kerja sama yang ada. • Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat. 5. Tanggung Jawab • Bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada. • Bertanggungjawab atas pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik rumah sakit. 6. Wewenang : • Menandatangani surat pesanan obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. • Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga farmasi dari segi jumlah maupun kualifikasi di instalasi farmasi. • Mengevaluasi perencanaan kebutuhan dan mengajukan permintaan pengadaan barang-barang farmasi baik untuk bulanan ataupun persediaan harian. • Memantau penerimaan dan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. • Memantau pendistribusian dan penjualan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. • Memantau penerapan SOP dan mengevaluasi..
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
2	Apoteker Rawat Inap	1. Pendidikan : - Lulusan S1 Apoteker - Memiliki STRA dan SIPA Apoteker Pendamping yang masih berlaku, Surat sumpah Apoteker 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun 4. Uraian tugas : • Membantu menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. • Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas dan hal-hal terkait di unitnya. • Melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit.

		• Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. • Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksana. • Membantu menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. • Melaksanakan pelayanan farmasi klinik sesuai pedoman pelayanan farmasi dan standar prosedur operasional yang berlaku. 1. Pengkajian dan pelayanan Resep; 2. Penelusuran riwayat penggunaan Obat; 3. Rekonsiliasi Obat; 4. Pelayanan Informasi Obat (PIO); 5. Konseling; 6. visite; 7. Pemantauan Terapi Obat (PTO); 8. Monitoring Efek Samping Obat (MESO); 9. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); 10. Dispensing sediaan steril. • Memelihara peralatan medis agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. • Membantu melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit. • Membantu menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. • Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama staf maupun pasien dan keluarganya. • Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. • Melakukan Pencetakan, pengecekan, penyiapan etiket dan label. • Memberikan edukasi dan informasi obat • Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat. 5. Tanggung Jawab : • Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi. • Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan keseharian di Instalasi Farmasi 6. Wewenang • Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di instalasi farmasi rumah sakit. • Melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
3	Apoteker Rawat Jalan	1. Pendidikan : - Lulusan S1 Apoteker - Memiliki STRA dan SIPA Apoteker Pendamping yang masih berlaku, Surat sumpah Apoteker 2. Pengetahuan dan Keterampilan :

		Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun 4. Uraian tugas : • Membantu menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. • Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas dan hal-hal terkait di unitnya. • Melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. • Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. • Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. • Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksana. • Membantu menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. • Melaksanakan pelayanan farmasi klinik sesuai pedoman pelayanan farmasi dan standar prosedur operasional yang berlaku. 1. Pengkajian dan pelayanan Resep; 2. Penelusuran riwayat penggunaan Obat; 3. Pelayanan Informasi Obat (PIO); 4. Konseling; 5. Monitoring Efek Samping Obat (MESO); 6. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); 7. Dispensing sediaan steril. • Memelihara peralatan medis agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. • Membantu melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit. • Membantu menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. • Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama staf maupun pasien dan keluarganya. • Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. • Melakukan Pencetakan, pengecekan, penyiapan etiket dan label. • Memberikan edukasi dan informasi obat • Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat. 5. Tanggung Jawab : • Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi. • Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan
--	--	--

		keseharian di Instalasi Farmasi 6. Wewenang • Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di instalasi farmasi rumah sakit. • Melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
4	Apoteker Gudang Farmasi	1. Pendidikan : - Lulusan S1 Apoteker - Memiliki STRA Seumur Hidup dan SIPA Apoteker Pendamping yang masih berlaku, Surat sumpah Apoteker 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang manajemen logistik minimal 1 tahun 4. Uraian tugas • Memilih sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit. • Merencanakan kebutuhan sediaan farmasi secara optimal. • Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. • memproduksi sediaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan . • Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi yang berlaku. • Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian; • Mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai ke masing-masing unit pelayanan di rumah sakit; • Memusnahkan dan menarik sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi persyaratan mutu. • Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. • Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan 5. Tanggung Jawab • Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi. 6. Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan keseharian di Instalasi Farmasi Wewenang • Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di gudang instalasi farmasi rumah sakit meliputi penerimaan, distribusi, dan produksi sediaan farmasi.

		Melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.
No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
4	Tenaga Vokasi Farmasi	4. Pendidikan : • Lulusan D3 Farmasi • Memiliki STR Tenaga Vokasi Farmasi Level 5 dan SIPTVF 5. Pengetahuan dan Keterampilan : Keterampilan dalam pelayanan Farmasi 6. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun 7. Uraian Tugas • Membantu apoteker untuk melakukan tugas rutin di instalasi farmasi rumah sakit. • Memeriksa ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di unit kerja. • Memeriksa persediaan sediaan farmasi yang mendekati waktu kadaluarsa. • Membuat usulan penanganan obat yang mendekati tanggal kadaluarsa. • Menerima dan melakukan menyimpan sediaan farmasi sesuai golongannya • Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai sifat fisika dan kimia berdasarkan informasi dalam kemasan. • Melakukan telaah resep dibawah pengawasan apoteker. • Melakukan penempelan label untuk obat yang memiliki kewaspadaan tinggi dan LASA. • Menyiapkan sediaan farmasi sesuai prosedur. • Meracik sediaan farmasi di bawah pengawasan apoteker. • Menulis etiket dan menempelkan label pada kemasan. • Melakukan Pencetakan, pengecekan, penyiapan etiket dan label. • Memberikan edukasi dan informasi obat dibawah pengawasan apoteker. • Melakukan penyiapan sediaan steril dibawah pengawasan apoteker. 8. Tanggung Jawab • Bertanggung jawab kepada Apoteker dan Kepala Instalasi, • Bertanggung jawab atas pelayanan keseharian di Instalasi Farmasi Wewenang : Memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dibawah pengawasan apoteker.

6.2 TUGAS KLINIS

Tugas klinis yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dan dilengkapi oleh SPK dan RKK

a. Apoteker

NO	KOMPETENSI
1.	PERENCANAAN
	a. Dapat mengajukan seleksi perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Kepala Instalasi.
	b. Memberikan pertimbangan pemilihan/ penggunaan obat dalam suatu kurun waktu
2.	PENGADAAN
	a. Memberikan pengumpulan data pendukung terhadap seleksi kebutuhan pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
	b. Memberikan perhitungan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).
	c. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan metode teknis pengadaan (Konsumsi, <i>Always Better Control</i> (ABC), <i>Vital, Essential & NonEssential</i> (VEN), <i>Evidence Base Medicine</i> (EBM) .
	d. Memberikan penilaian tentang jumlah dan kesesuaian antara kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan dana.
	e. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan pemasok/penyedia sediaan farmasi dan alat kesehatan
	f. Membuat surat pemesanan barang.
	g. Memantau proses pengadaan.
	h. Memantau dan evaluasi pengadaan obat baru.
	i. Memantau dan menganalisis kekosongan obat.
	j. Memantau proses pembayaran.
	k. Melakukan proses monitoring dan evaluasi sistem pengadaan di RS.
	l. Melakukan dokumentasi kegiatan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).
3.	PENERIMAAN
	a. Menerima faktur pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).
	b. Mengecek kondisi kemasan seperti yang disyaratkan, jumlah satuan dalam tiap kemasan, kebenaran identitas produk, jangka waktu kadaluarsa, jenis produk dan harga sesuai dengan surat pemesanan barang.
	c. Mengecek kesesuaian suhu saat penerimaan sediaan farmasi <i>Cold Chain Product</i> (CCP) sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
	d. Menerima faktur pembelian sediaan narkotika dan psikotropika, obat-obat tertentu (OOT) dan Prekursor.
	e. Melakukan dokumentasi kegiatan penerimaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
4.	PENYIMPANAN
	a. Melakukan monitoring suhu dan kelembaban penyimpanan.
	b. Melakukan monitoring penyimpanan berdasarkan stabilitas suhu yang diperlukan, penataan sesuai alfabetis, pengelompokan bentuk sediaan dan rute pemberian obat, kesesuaian penataan dengan prinsip <i>First Expired First Out</i> (FEFO) dan <i>First In First Out</i> (FIFO).
	c. Melakukan monitoring terkait penyimpanan dan penempelan label/stiker penandaan obat <i>Look Alike Sound Alike</i> (LASA) dan <i>High Alert</i> .
	d. Melakukan supervisi terkait penyimpanan dan penempelan label/stiker penandaan sediaan B3, gas medis dan obat radioaktif.
	e. Melakukan monitoring terkait penyimpanan sediaan obat narkotika dan psikotropika, obat-obat tertentu (OOT) dan prekursor.
	f. Melakukan supervisi penyimpanan <i>floor stock</i> yang tersedia di unit RS.
	g. Melakukan supervisi terkait <i>box emergency</i> (BE) yang tersedia di unit RS.
5.	DISTRIBUSI

	a. Melakukan penyiapan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan didistribusikan/dialurkan.
	b. Melakukan pengemasan dan pelabelan sediaan repacking.
	c. Melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan alat kesehatan secara <i>Unit Dose Dispensing (UDD)</i> , <i>floor stock</i> , dan <i>individual prescribing</i> .
	d. Melakukan pencatatan kartu stok pemasukan dan pengeluaran.
	e. Melakukan pendistribusian <i>Cold Chain Product (CCP)</i> .
	f. Melakukan supervisi dan laporan evaluasi terkait kegiatan distribusi di RS.
	g. Melakukan dokumentasi kegiatan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
6.	PENARIKAN dan PEMUSNAHAN
	a. Melakukan penarikan (<i>Recall</i>) sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) substandar.
	b. Melakukan identifikasi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) yang akan dimusnahkan.
	c. Melakukan karantina sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terpisah yang akan dimusnahkan.
	d. Melakukan kegiatan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
	e. Melakukan dokumentasi kegiatan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).
7.	PELAYANAN RESEP
	a. Melakukan pengkajian administratif, farmasetik dan klinis.
	b. Membuat laporan kajian data terkait kesesuaian e-resep dan peresepan di luar formularium.
	c. Melakukan pengarsipan resep berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.	DISPENSING SEDIAAN STERIL DAN NON STERIL
	a. Melakukan penyiapan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai peresepan.
	b. Melakukan perhitungan kebutuhan sediaan steril dan non steril untuk peracikan dan rekonstitusi.
	c. Melakukan penyiapan dan rekonstitusi sediaan steril menggunakan teknik aseptis.
	d. Melakukan penyiapan, peracikan dan rekonstitusi sediaan non steril.
	e. Melakukan monitoring dan supervisi terkait penyiapan, pengemasan, dan pelabelan/pemberian etiket sediaan farmasi yang akan didistribusikan kepada pasien dan atau tenaga medis lain sesuai peresepan.
	f. Melakukan penyiapan obat narkotika/psikotropika.
	g. Melakukan monitoring terkait kebersihan, kerapian, dan kesesuaian tempat kerja untuk penyiapan, peracikan dan rekonstitusi sediaan steril dan non steril.
	h. Melakukan dokumentasi kegiatan penyiapan, peracikan dan rekonstitusi sediaan steril dan non steril
9.	REKONSILIASI OBAT
	a. Melakukan penelusuran informasi riwayat pengobatan pasien.
	b. Melakukan penelusuran data riwayat penggunaan obat dari rekam medis.
	c. Melakukan rekonsiliasi admisi, transfer dan <i>discharge</i> .
	d. Melakukan dokumentasi kegiatan rekonsiliasi obat.
10.	KONSELING DAN PEMBERIAN INFORMASI OBAT
	a. Memberikan konseling kepada pasien sesuai prosedur yang ditetapkan.
	b. Memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien, keluarga pasien dan atau tenaga medis lain menggunakan komunikasi yang efektif.
	c. Melakukan dokumentasi kegiatan konseling dan pemberian informasi obat.
11.	VISITE
	a. Melakukan visite pasien di rawat inap.
	b. Melakukan dokumentasi hasil visite pasien di lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dan formulir edukasi.
	c. Memberikan rekomendasi terkait pengobatan jika terjadi alergi dan ROTD/ESO.
12.	PEMANTAUAN TERAPI OBAT

	a. Melakukan pemantauan terapi obat pada kriteria pasien yang telah ditentukan.
	b. Memberikan rekomendasi waktu pemberian obat dengan mempertimbangkan interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan.
	c. Memberikan rekomendasi terkait pengobatan jika terjadi alergi dan ROTD/ESO.
13.	MONITORING EFEK SAMPING OBAT (ESO) / REAKSI OBAT TIDAK DIINGINKAN (ROTD)
	a. Melakukan monitoring terkait efek samping obat.
	b. Melakukan dokumentasi monitoring efek samping obat menggunakan formulir MESO kuning dan atau melalui website https://e-meso.pom.go.id/
	c. Memberikan rekomendasi penanganan jika terjadi efek samping obat.
14.	CATATAN PENGGUNAAN OBAT PASIEN
	a. Melakukan monitoring pengobatan pasien dari rumah.
	b. Melakukan monitoring pengobatan pasien secara mandiri.
	c. Melakukan monitoring pengobatan pasien selama rawat inap.
15.	PELAPORAN DAN PENCATATAN
	a. Melakukan evaluasi dengan kartu stok, monitoring expired date (ED)/kadaluwarsa dan perhitungan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara keseluruhan (stok opname).
	b. Pelaporan pelayanan kefarmasian pada website KEMENKES (SIPNAP, SIMONA, SIHA, SITB, E-MONEV, SMILE)
16.	KODE ETIK
	a. Menerapkan Kode Etik dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia dalam praktik sehari-hari.
	b. Menerapkan pertimbangan profesional dalam melakukan praktik kefarmasian dengan mengindahkan kode etik dan disiplin.
	c. Menjelaskan ketentuan perundangan bidang kefarmasian secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum dan penerapannya dalam praktik.

b. Tenaga Vokasi Farmasi

NO	KOMPETENSI
1.	PERENCANAAN
	a. Dapat mengajukan seleksi perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Kepala Instalasi.
	b. Memberikan pertimbangan pemilihan/ penggunaan obat dalam suatu kurun waktu
2.	PENGADAAN
	a. Memberikan pengumpulan data pendukung terhadap seleksi kebutuhan pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
	b. Memberikan perhitungan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).
	c. Memberikan penilaian tentang jumlah dan kesesuaian antara kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan dana.
	d. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan pemasok/penyedia sediaan farmasi dan alat kesehatan
	e. Membuat surat pemesanan barang.
	f. Memantau proses pengadaan.
	g. Memantau dan evaluasi pengadaan obat baru.
	h. Memantau dan menganalisis kekosongan obat.
	i. Memantau proses pembayaran.
	j. Melakukan proses monitoring dan evaluasi sistem pengadaan di RS.
	k. Melakukan dokumentasi kegiatan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).
3.	PENERIMAAN
	a. Menerima faktur pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).
	b. Mengecek kondisi kemasan seperti yang disyaratkan, jumlah satuan dalam tiap kemasan, kebenaran identitas produk, jangka waktu kadaluarsa, jenis produk dan harga sesuai dengan surat pemesanan barang.
	c. Mengecek kesesuaian suhu saat penerimaan sediaan farmasi <i>Cold Chain</i>

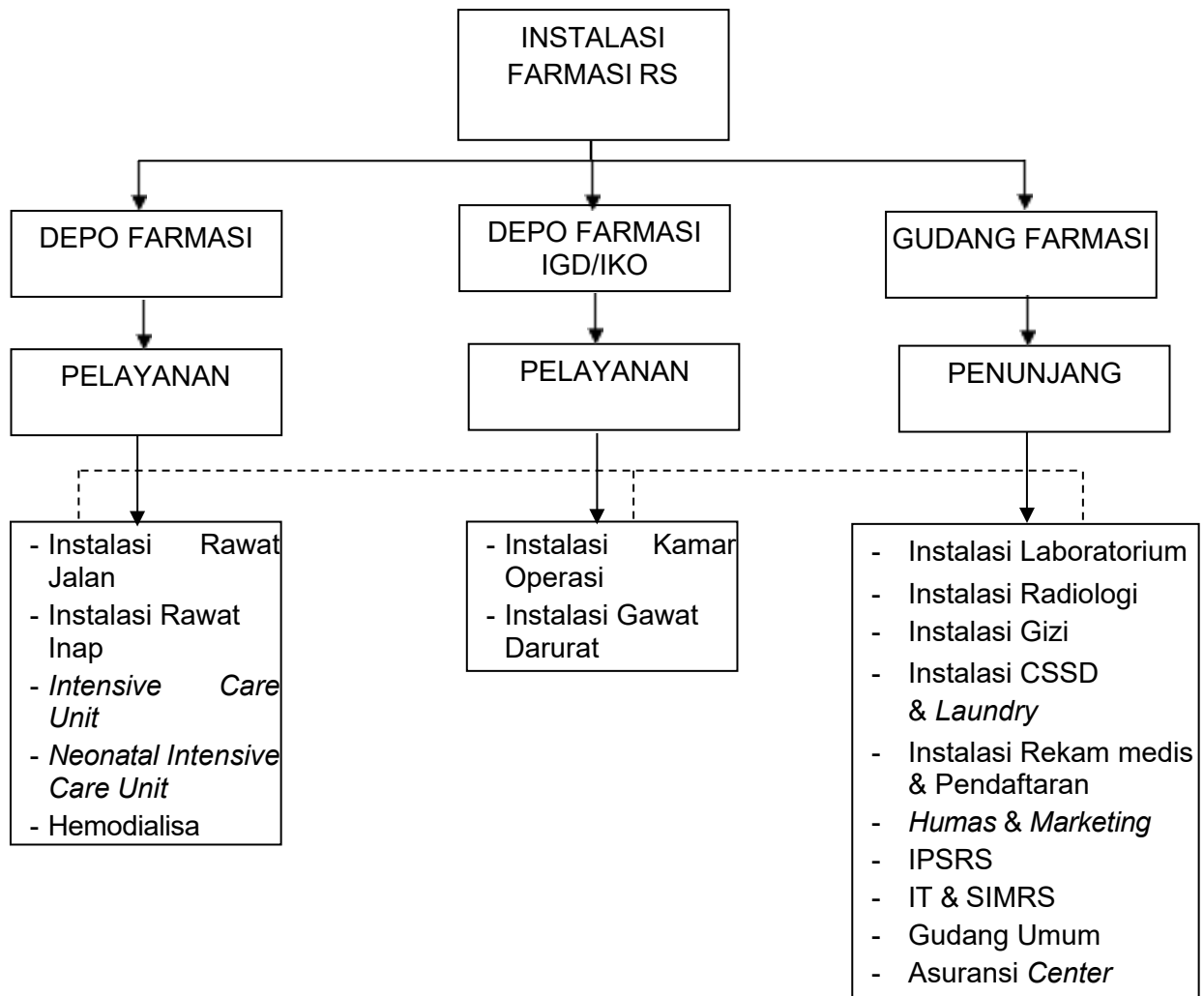
	<i>Product (CCP)</i> sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. d. Melakukan dokumentasi kegiatan penerimaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
4.	PENYIMPANAN a. Melakukan monitoring suhu dan kelembaban penyimpanan. b. Melakukan monitoring penyimpanan berdasarkan stabilitas suhu yang diperlukan, penataan sesuai alfabetis, pengelompokan bentuk sediaan dan rute pemberian obat, kesesuaian penataan dengan prinsip <i>First Expired First Out</i> (FEFO) dan <i>First In First Out</i> (FIFO). c. Melakukan monitoring terkait penyimpanan dan penempelan label/stiker penandaan obat <i>Look Alike Sound Alike</i> (LASA) dan <i>High Alert</i>. d. Melakukan supervisi terkait penyimpanan dan penempelan label/stiker penandaan sediaan B3, gas medis dan obat radioaktif. e. Melakukan monitoring terkait penyimpanan sediaan obat narkotika dan psikotropika, obat-obat tertentu (OOT) dan prekursor. f. Melakukan supervisi penyimpanan <i>floor stock</i> yang tersedia di unit RS. g. Melakukan supervisi terkait <i>box emergency</i> (BE) yang tersedia di unit RS.
5.	DISTRIBUSI a. Melakukan penyiapan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan didistribusikan/dialurkan. b. Melakukan pengemasan dan pelabelan sediaan repacking. c. Melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan alat kesehatan secara <i>Unit Dose Dispensing</i> (UDD), <i>floor stock</i>, dan <i>individual prescribing</i>. d. Melakukan pencatatan kartu stok pemasukan dan pengeluaran. e. Melakukan pendistribusian <i>Cold Chain Product</i> (CCP). f. Melakukan supervisi dan laporan evaluasi terkait kegiatan distribusi di RS. g. Melakukan dokumentasi kegiatan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
6.	PENARIKAN dan PEMUSNAHAN a. Melakukan penarikan (<i>Recall</i>) sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) substandar. b. Melakukan identifikasi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) yang akan dimusnahkan. c. Melakukan karantina sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terpisah yang akan dimusnahkan. d. Melakukan kegiatan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai prosedur yang telah ditetapkan. e. Melakukan dokumentasi kegiatan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, vaksin, reagen, bahan berbahaya dan beracun (B3).
7.	PELAYANAN RESEP a. Melakukan pengkajian administratif, farmasetik dan klinis (dalam supervisi). b. Membuat laporan kajian data terkait kesesuaian e-resep dan peresepan di luar formularium. c. Melakukan pengarsipan resep berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.	DISPENSING SEDIAAN STERIL DAN NON STERIL a. Melakukan penyiapan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai peresepan. b. Melakukan perhitungan kebutuhan sediaan steril dan non steril untuk peracikan dan rekonstitusi. c. Melakukan penyiapan dan rekonstitusi sediaan steril menggunakan teknik aseptis. d. Melakukan penyiapan, peracikan dan rekonstitusi sediaan non steril. e. Melakukan monitoring dan supervisi terkait penyiapan, pengemasan, dan pelabelan/pemberian etiket sediaan farmasi yang akan di distribusikan kepada pasien dan atau tenaga medis lain sesuai peresepan. f. Melakukan penyiapan obat narkotika/psikotropika. g. Melakukan monitoring terkait kebersihan, kerapian, dan kesesuaian tempat kerja untuk penyiapan, peracikan dan rekonstitusi sediaan steril dan non steril. h. Melakukan dokumentasi kegiatan penyiapan, peracikan dan rekonstitusi sediaan steril dan non steril

9.	REKONSILIASI OBAT
	a. Melakukan penelusuran informasi riwayat pengobatan pasien. b. Melakukan penelusuran data riwayat penggunaan obat dari rekam medis.
10.	KONSELING DAN PEMBERIAN INFORMASI OBAT
	a. Memberikan konseling kepada pasien sesuai prosedur yang ditetapkan. b. Memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien, keluarga pasien dan atau tenaga medis lain menggunakan komunikasi yang efektif. c. Melakukan dokumentasi kegiatan konseling dan pemberian informasi obat.
	11. MONITORING EFEK SAMPING OBAT (ESO) / REAKSI OBAT TIDAK DIINGINKAN (ROTD)
11.	a. Melakukan monitoring terkait efek samping obat. b. Melakukan dokumentasi monitoring efek samping obat menggunakan formulir MESO kuning dan atau melalui website https://e-meso.pom.go.id/ c. Memberikan rekomendasi penanganan jika terjadi efek samping obat.
	12. CATATAN PENGGUNAAN OBAT PASIEN
	a. Melakukan monitoring pengobatan pasien dari rumah. b. Melakukan monitoring pengobatan pasien secara mandiri. c. Melakukan monitoring pengobatan pasien selama rawat inap.
13.	PELAPORAN DAN PENCATATAN
	Melakukan evaluasi dengan kartu stok, monitoring expired date (ED)/kadaluwarsa dan perhitungan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara keseluruhan (stok opname).
14.	KODE ETIK
	a. Menerapkan Kode Etik dan Pedoman Disiplin Tenaga Vokasi Farmasi Indonesia dalam praktik sehari-hari. b. Menerapkan pertimbangan profesional dalam melakukan praktik kefarmasian dengan mengindahkan kode etik dan disiplin. c. Menjelaskan ketentuan perundangan bidang kefarmasian secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum dan penerapannya dalam praktik.

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

7.1 Tata Hubungan Kerja



7.2 Pola Hubungan Pelayanan

7.2.1 Pola Hubungan dengan Instalasi/ Unit Pelayanan Struktural

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. 2. Pelayanan resep pasien IGD. 3. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i>. 4. Supervisi apoteker di IGD.
2.	Instalasi Kamar Operasi (IKO)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Pelayanan resep IKO. 2. Pelayanan resep pasien IKO. 3. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i>. 4. Supervisi apoteker di IKO.
3.	Instalasi Rawat Inap (IRNA)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. 2. Pelayanan resep pasien rawat inap. 3. Visite pasien rawat inap. 4. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i>. 5. Supervisi harian dan mingguan apoteker di rawat inap. 6. Pengisian rekam medis. 7. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker.
4.	Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. 2. Pelayanan resep pasien rawat jalan. 3. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i>. 4. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker. 5. Supervisi mingguan apoteker.
5.	<i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 2. Pelayanan Resep pasien ICU. 3. Visite pasien ICU. 4. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i>. 5. Supervisi harian dan mingguan apoteker di ICU. 6. Pengisian rekam medis. 7. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker.
6.	<i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 2. Pelayanan Resep pasien NICU. 3. Visite pasien NICU. 4. Pengecekan <i>box dan trolley emergency</i>. 5. Supervisi harian dan mingguan apoteker di NICU. 6. Pengisian rekam medis. 7. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker.

7.	Hemodialisa	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. 2. Pelayanan resep pasien hemodialisa. 3. Visite pasien hemodialisa. 4. Pengecekan <i>box dan trolly emergency</i>. 5. Supervisi harian dan mingguan apoteker di hemodialisa. 6. Pengisian rekam medis. 7. Pelayanan farmasi klinik oleh apoteker.
----	-------------	---

7.2.2 Pola Hubungan dengan Instalasi/ Unit Penunjang

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSR)	1. Perbaikan peralatan dan sarana instalasi farmasi. 2. Pengkondisian lingkungan area instalasi farmasi. 3. Manajemen aset pembelian alat kesehatan oleh Gudang Farmasi
2.	Instalasi Rekam Medis & Pendaftaran	1. Laporan bulanan dan tahunan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan 2. Kelengkapan pengisian rekam medis. 3. Keperluan data dan dokumen. 4. Menyediakan kebutuhan unit berupa BMHP.
3.	Instalasi Laboratorium	1. Menyediakan kebutuhan unit berupa Sediaan Farmasi, BMHP, Alat kesehatan dan Reagen sesuai kebutuhan. 2. Supervisi harian dan mingguan apoteker di Laboratorium.
4.	Asuransi Center	1. Laporan obat kronis pasien BPJS. 2. Laporan penjualan alat kesehatan khusus pasien BPJS. 3. Laporan penjualan alat kesehatan khusus pasien BPJS. 4. Laporan penjualan resep pasien asuransi. 5. Laporan penggunaan implan pasien operasi.
5.	Humas dan Marketing	1. Survei kepuasan Pasien. 2. Standar Pelayanan Minimal. 3. Menyediakan kebutuhan <i>Medical Check Up</i> berupa Sediaan Farmasi, BMHP dan Alat kesehatan sesuai kebutuhan.
6.	IT & SIMRS	1. Pengecekan komputer dan perangkatnya. 2. Pemeliharaan program SIMRS.
7.	Gudang Umum	Pemenuhan kebutuhan Alat tulis kantor (ATK) sesuai kebutuhan Instalasi Farmasi.
8.	Instalasi CSSD dan Laundry	Menyediakan kebutuhan unit berupa BMHP sesuai kebutuhan.
9.	Instalasi Radiologi	Menyediakan kebutuhan unit berupa BMHP sesuai kebutuhan.
10.	Instalasi Gizi	1. Menyediakan kebutuhan unit berupa BMHP sesuai kebutuhan. 2. Berkolaborasi dalam pertimbangan asupan nutrisi, interaksi obat dan makanan dalam meningkatkan kualitas hidup Pasien rawat inap.

BAB VIII

POLA KETENAGAAN

8.1 Pola Ketenagaan

Dalam upaya mempersiapkan tenaga farmasi yang handal perlu adanya perencanaan SDM. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber daya manusia tersebut seefektif mungkin dapat memenuhi kebutuhan tenaga sesuai dengan persyaratan jabatan. Berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014 dan Permenkes 72 tahun 2016 maka :

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH SDM		Keterangan
		STANDAR	KONDISI SAAT INI	
1	Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit	1 orang	1 orang	sesuai
2	Apoteker Gudang Farmasi	1 orang	1 orang	sesuai
3	Apoteker Rawat Jalan	7 orang	5 orang	tidak sesuai
4	Apoteker Rawat Inap	6 orang	5 orang	tidak sesuai
5	Tenaga Vokasi Depo Farmasi	33 orang	28 orang	tidak sesuai
6	Tenaga Vokasi Depo Farmasi IGD/IKO	4 orang	4 orang	sesuai
7	Tenaga Vokasi Gudang Farmasi	2 orang	2 orang	sesuai

8.2 Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan

kompetensi, kebutuhan pasien atau kekurangan staf.

- Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut.
- Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut dirotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
- b. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan dan agama. Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen atau bahkan *marketing* yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf. Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 - Staf dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya;
 - Bagi staf yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh: penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara)

8.3 Evaluasi Dan Pemutakhiran Staf

- a. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
- b. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Unit, SDM
- c. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
- d. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

8.4 Seleksi Calon Staf

Seleksi calon staf adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon staf dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon staf dapat dibagi dua yaitu:

1. Dari dalam Rumah Sakit Prima Husada sendiri (*internal resources*)
Menarik calon dari dalam RS Prima Husada sendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada
2. Dari luar RS. Prima Husada (*external resources*)
Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Kriteria calon staf menurut standar IFRS RS Prima Husada :

1. Apoteker
 - a. Lulusan S1 Farmasi dan Profesi Apoteker.
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK Apoteker minimal 3,00.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Diutamakan apoteker dengan penjurusan klinis.
 - f. Memiliki pemahaman tentang Pelayanan Farmasi RS dengan baik.
 - g. Memahami Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
 - h. Dapat bekerja secara mandiri dan tim.
2. Tenaga Teknis Kefarmasian
 - a. Lulusan D3 Farmasi.
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK minimal 3,00.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memahami Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
 - f. Dapat bekerja secara mandiri dan tim.

8.5 Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Farmasi khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga farmasi. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan farmasi. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Pendidikan

Tenaga dengan pendidikan setingkat SMA diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan DIII.

2. Pelatihan

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi di Instalasi Farmasi dilaksanakan melalui :

- a. *Internal Training* yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD.
- b. *External Training* yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi Farmasi.

BAB IX

KEGIATAN ORIENTASI

9.1 Orientasi Apoteker

HARI KE-	MATERI	WAKTU	METODE	PENANG GUNG JAWAB
1	Penjelasan status kepegawaian Penjelasan program orientasi yang akan diterima staf, peraturan dan tata tertib masa orientasi Kepada staf dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Orientasi di unit kerja dimana staf ditempatkan Staf diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : 1. Visi, misi, nilai, struktur organisasi 2. Perjanjian kerja 3. Etika bekerja 4. Kesejahteraan spiritual 5. Service excellence 6. Handling complaints 7. Produk produk rumah sakit 8. <i>Basic life support</i> 9. Penanggulanganbencana kebakaran 10. Patient safety 11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah dan diskusi	SDM
2	Mempelajari SPO Instalasi Farmasi. Mempelajari Pedoman Pelayanan IFRS Mempelajari Pedoman Organisasi Instalasi Farmasi Mempelajari Panduan UDD Mempelajari Panduan <i>High Alert</i> Mempelajari Panduan Resep Mempelajari SIMRS	4 jam	Ceramah, membaca dan diskusi	Kepala IFRS

3	Mempelajari dan praktek alur pelayanan farmasi rawat jalan. Pengkajian resep rawat jalan. Menyiapkan dan etiket obat pasien rawat jalan. Menyerahkan obat dan KIE pasien rawat jalan. Checklist dan format data yang harus dikerjakan tiap akhir shift.	5 jam	Ceramah, diskusi dan praktek	Apoteker rawat jalan
4	Mempelajari dan praktek alur pelayanan farmasi rawat inap dengan sistem UDD. Pengisian Form Daftar Pemberian Obat pasien rawat Inap. Pengisian RM pasien. Visite apoteker. Menyiapkan dan etiket obat rekonstitusi. Dispensing sediaan steril di ruang LAF.	7 jam	Ceramah, diskusi dan praktek	Apoteker rawat inap
5	Mempelajari dan praktek alur pelayanan Gudang Farmasi. Mempelajari proses permintaan barang ke Gudang Farmasi. Mempelajari proses penerimaan barang dari Gudang Farmasi. Proses penyimpanan obat di Gudang Farmasi. Mempelajari cara penerimaan barang dari distributor. Mempelajari cara pemesanan barang ke distributor.	7 jam	Ceramah, diskusi dan praktek	Kepala IFRS

9.2 Orientasi Tenaga Vokasi Farmasi

HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	Penjelasan status kepegawaian Penjelasan program orientasi yang akan diterima staf, peraturan dan tata tertib masa orientasi Kepada staf dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Orientasi di unit kerja dimana staf ditempatkan Staf diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : a. Visi, misi, nilai, struktur organisasi b. Perjanjian kerja c. Etika bekerja d. Kesejahteraan spiritual e. <i>Service excellence</i> f. <i>Handling complaints</i> g. Produk produk rumah sakit h. <i>Basic life support</i> i. Penanggulangan bencana kebakaran j. Patient safety k. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah dan diskusi	SDM
2	Mempelajari SPO Instalasi Farmasi. Mempelajari Pedoman Pelayanan IFRS Mempelajari Pedoman Organisasi Instalasi Farmasi Mempelajari Panduan Visite Apoteker Mempelajari Panduan UDD Mempelajari Panduan <i>High Alert</i> Mempelajari Panduan Resep Mempelajari SIMRS	4 jam	Ceramah, membaca , dan diskusi	Kepala IFRS

	Mempelajari dan praktek alur pelayanan farmasi rawat jalan. Pengkajian resep rawat jalan. Menyiapkan dan etiket obat pasien rawat jalan. Menyerahkan obat dan KIE pasien rawat jalan. Checklist dan format data yang harus dikerjakan tiap akhir shift.	3 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Apoteker rawat jalan
3	Mempelajari dan praktek alur pelayanan farmasi rawat inap. Pengkajian resep rawat inap. Menyiapkan dan etiket obat pasien rawat inap dengan sistem UDD dan pasien IGD. Serah terima obat dengan sistem UDD. Menyerahkan dan KIE pasien rawat inap dan IGD. Checklist dan format data yang harus dikerjakan tiap akhir shift.	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Apoteker rawat inap
4	Mempelajari dan praktek alur pelayanan Gudang Farmasi. Mempelajari proses permintaan barang ke Gudang Farmasi. Mempelajari proses penerimaan barang dari Gudang Farmasi. Proses penyimpanan obat di Gudang Farmasi. Mempelajari cara penerimaan barang dari distributor. Mempelajari cara pemesanan barang ke distributor.	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Apoteker Gudang Farmasi

BAB X

PERTEMUAN RAPAT

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Tujuannya sebagai berikut :

1. Dapat membantu terselenggaranya pelayanan farmasi yang profesional di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada.
2. Dapat menggali segala permasalahan terkait dengan pemberian pelayanan di Instalasi Farmasi.
3. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan pelayanan di Instalasi Farmasi.

Rapat terdiri dari 2 macam yaitu :

Rapat Rutin

1. Rapat koordinasi antar unit diselenggarakan 1 bulan sekali. Rapat ini dihadiri oleh kepala instalasi, kepala ruang dan unit-unit terkait untuk membahas tentang koordinasi antar unit dalam satu RS.
2. Rapat internal Instalasi Farmasi dilakukan pada minggu pertama 1 bulan sekali. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim Instalasi Farmasi RSPH dan Kepala Bidang Penunjang Medis untuk membahas permasalahan internal ataupun eksternal, koordinasi internal, *update* keilmuan dan lain-lain.

Rapat Insidentil

Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan sosialisasi kebijakan baru.

BAB XI

PELAPORAN

Berikut data laporan instalasi farmasi meliputi :

No	Jenis Laporan	Nama Laporan	Uraian Laporan
1.	Laporan Harian	Laporan rekapan harian	Laporan rekapan harian meliputi tanggal laporan, shift yang bertugas, total resep keseluruhan, total reseprawat jalan dan rawat inap, total resep umum, total resep BPJS, total resep asuransi lain, yang dilakukan oleh tenaga vokasi farmasi setiap harinya. Apoteker yang bertanggungjawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada kepala instalasi setiap bulan.
		Laporan sensus harian	Laporan sensus harian meliputi tanggal laporan, shift yang bertugas, jumlah kesalahan, prosentase kesalahan, petugas tenaga vokasi farmasi yang melakukan kesalahan dan total keseluruhan resep yang dilakukan oleh tenaga vokasi farmasi setiap harinya. Apoteker yang bertanggungjawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada kepala instalasi setiap bulan.
		Laporan indikator mutu	Laporan indikator mutu meliputi judul indikator mutu instalasi farmasi yang dikumpulkan oleh penanggungjawab pengumpul data. Apoteker yang bertanggungjawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada kepala instalasi setiap bulan.
2.	Laporan Bulanan	Laporan penggunaan obatnarkotika dan psiko-tropika	Laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika dilaporkan oleh kepala instalasi farmasi melalui SIPNAP secara <i>online</i> . Data penggunaan diperoleh dari kesesuaian resep dengan data peresepan pada SIMRS. Data tersebut yang menjadi data pelaporan narkotika dan psikotropika tiap bulannya.
		Laporan jadwal dinas tenaga	Laporan jadwal dinas Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi disusun oleh Kepala Instalasi Farmasi yang disetujui oleh kepala bidang penunjang medis.

		kefarmasian	
		Laporan <i>stok opname</i>	Laporan <i>stok opname</i> dilaporkan oleh Kepala Instalasi Farmasi kepada Direktur Rumah Sakit dan PT Disa Prima Medika.
		Laporan bulanan unit	Laporan bulanan unit disusun oleh Kepala Instalasi farmasi yang melaporkan kebutuhan jumlah SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, kinerja produktivitas, mutu, evaluasi jadwal kegiatan, serta kritik dan saran dalam rangka perbaikan instalasi farmasi.
3.	Laporan Tahunan	Laporan akhir tahun IFRS	Laporan akhir tahun IFRS berisikan rekapitulasi tahunan pelayanan resep yang disusun oleh Kepala Instalasi Farmasi dibantu apoteker dalam mengolah data yang diperoleh dari hasil rekapan pelayanan resep tiap hari yang dilakukan oleh tenaga vokasi farmasi. Laporan rekapitulasi tahunan ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan resep di instalasi farmasi sehingga dapat dilakukan perencanaan penambahan SDM apabila diperlukan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep